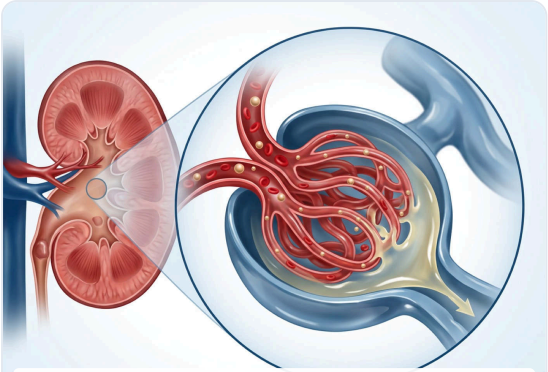
신장기능 eGFR·단백뇨 결과 안내

eGFR은 혈액검사로 추정한 콩팥 여과 능력, 단백뇨·알부민뇨는 소변으로 단백이 새는 정도를 봅니다. 한 번의 이상만으로 만성콩팥병을 확정하지 않고, 반복 확인과 위험도 평가가 필요합니다.

수치가 뜻하는 것



콩팥 필터(사구체)가 피를 거르는 모습

수치	뜻 (KDIGO 2024 기준)
eGFR 90 이상	**정상**(KDIGO 1단계)
eGFR 60~89	**약간 감소**(KDIGO 2단계) — 단백뇨·혈뇨 등 다른 콩팥 이상이 없으면 만성콩팥병이 아니며, 다른 이상이 함께 있으면 추적
eGFR 60 미만	**3개월 이상 계속되면 만성콩팥병**
uACR 30 이상	소변 알부민 30 mg/g 이상이면 **추적**

국가건강검진 결과지는 60 이상을 '정상'으로 판정합니다 — 60~89도 검진 판정은 정상이지만 다른 이상이 있으면 추적합니다.

근육이 적은 고령자·저체중 환자는 크레아티닌이 낮아 기능이 좋게 보일 수 있습니다. (아산28 · eGFR을 고려한 만성콩팥병의 실제적 관리(장재원)) NSAIDs·COX-2 억제제, 이뇨제 등 복용약을 확인합니다. 장재원 강의는 GFR <60에서 경구 인산나트륨 장정결제를 금기로 설명합니다. (아산28 · eGFR을 고려한 만성콩팥병의 실제적 관리(장재원))

왜 재검이 필요한가요?

일시적으로 나빠질 수 있는 경우	다음 확인 검사
탈수·금식 — 크레아티닌 상승, 소변 농축	**크레아티닌/eGFR 재검** — 대개 1~3개월 간격
격한 운동 — 일시적 혈뇨·단백뇨 가능	**소변 알부민·크레아티닌 비(uACR)** — 거품 여부가 아니라 소변검사로 단백(알부민)이 새는 양을 정확히 잽니다. 30 mg/g 이상이면 추적
감기·발열·요로감염 — 소변 이상 동반 가능	**혈압·당뇨 평가** — 콩팥 손상의 가장 흔한 원인
진통소염제 — 소염진통제 복용 시 신장 부담 증가	**소변 침사·초음파** — 혈뇨, 결석, 구조 이상 확인
크레아틴 보충제 — 크레아티닌이 올라 eGFR이 가짜 저하로 나올 수 있음	**소변검사 준비** — 소변이 진하면 단백뇨처럼 보일 수 있어(가짜 단백뇨), 소변검사만 있는 날은 평소처럼 물을 드세요

콩팥을 지키는 생활 원칙

줄일 것

짠 음식 — 국물·젓갈·가공식품 줄이기

진통소염제 남용 — 이부프로펜·나프록센 등 상담 후

고단백 보충제 — eGFR 저하 시 무리한 섭취 피하기

흡연 — 혈관·콩팥 기능 악화와 연관

관리할 것

혈압 목표 확인 — 가정혈압 기록이 도움

혈당 관리 — 당뇨가 있으면 당화혈색소와 uACR 추적

수분 균형 — 탈수 피하되 심부전·부종은 별도 상담

정기 추적 — eGFR 변화 속도와 단백뇨가 핵심

칼륨 공포 — 신장수치가 조금 낮다고 과일·채소를 무조건 끊을 필요는 없음, 혈중 칼륨 수치로 판단

빨리 진료가 필요한 신호

소변량이 갑자기 줄거나, 전신 부종이 생기거나, 육안적 혈뇨·옆구리 통증·고열이 있으면 빨리 진료를 보세요. **소변이 거의 나오지 않거나 숨이 차면 응급실**로 가세요. eGFR이 30 미만, 단백뇨가 심함, 혈뇨와 단백뇨가 함께 지속되는 경우에는 전문 진료가 필요할 수 있습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — KDIGO 2024 CKD Guideline · KDIGO Potassium Controversies Conference(2020) · National Kidney Foundation eGFR/ACR 안내 · 국민건강보험공단 일반건강검진 판정기준

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 추적 간격과 약물 조정은 원인, 혈압·당뇨, 이전 수치 변화에 따라 달라집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/egfr-proteinuria/